

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN PERSALINAN DENGAN KOMPLIKASI EMBOLI KETUBAN		
	No. Dokumen 571.86/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Emboli air ketuban adalah kondisi ketika air ketuban masuk dan bercampur ke dalam system peredaran darah sang ibu, kondisi tersebut bisa terjadi saat atau setelah proses persalinan yang bisa menimbulkan resiko dna komplikasi pada ibu dan bayi	
Tujuan	1. Bidan RS mampu menganalisa dan memberikan Tindakan pada persalinan dengan komplikasi emboli ketuban 2. Menyiapkan semua perlengkapan alat, obat-obatan dan pasien dengan emboli ketuban 3. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) akibat emboli ketuban	
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.	
Prosedur	1. Siapkan alat 1.1. Siapkan alat-alat : a. Handscoon steril b. Under pad c. Baging d. Oxygen transport e. kassa f. O2 Nasal Canul / NRBM g. Infus set makro h. IV line i. Cairan infus RL500 cc / NS 500 cc j. Injeksi Oxytocin 10 IU k. Injeksi pospargin 1 amp l. Sput 3 cc,5 cc,10cc m. Urine bag n. Selang Cateter o. Otsu Wi 25 ml p. Partus set q. Monitor pasien 1.2 Dekat kan alat di samping pasien 1.3 Siapkan lingkungan pasien 2. Siapkan pasien 2.1 Lakukan Cuci tangan 6 langkah 2.2 Pakai APD sesuai standart (Celemek, masker, <i>google</i>, sepatu boot dan sarung tangan) 2.3 Perkenalkan diri pada pasien 2.4 Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) 2.5 Jelaskan pada keluarga dan pasien tentang hasil pemeriksaan 2.6 Jelaskan kepada keluarga pasien tujuan, prosedur	



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PENANGANAN PERSALINAN DENGAN KOMPLIKASI
EMBOLI KETUBAN

No. Dokumen
571.86/I-SPO/NEO/VI/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

tindakan dan resiko yang akan di alami ibu saat dilakukan tindakan

- 2.7 Posisikan pasien pada posisi litotomi
3. Rincian prosedur :
Jika pasien di temukan dalam kondisi Syok:
 - 3.1. Cuci tangan 6 langkah
 - 3.2. Pakai APD sesuai standart (Celemek, masker, *google*, sepatu boot dan sarung tangan)
 - 3.3. Lakukan penanganan ABC (*airway, breathing, circulation*)
 - 3.4. memberikan oksigen Nasal Canul 3-4 lpm atau NRBM 10- 15 lpm (sesuai dengan kondisi pasien saat dilakukan pemeriksaan)
 - 3.5. Lakukan perbaikan volume cairan dengan pasang infus
 - 3.6. Lakukan stabilisasi kondisi umum pasien
 - 3.7. Lakukan pemeriksaan umum dan khusus (Vital sign, pemeriksaan VT, kontraksi dan kemajuan persalinan
 - 3.8. Kolaborasi dengan dokter jaga
 - 3.9. Konsulkan kondisi pasien kepada dokter obygyn
 - a. Jika ditemukan pasien dengan inpartu kala II maka lakukan persiapan prosedur vacum ekstraksi oleh dokter obgyn (sesuai advis dokter obgyn)
 - b. Jika ditemukan pasien dengan inpartu fase laten - fase aktif maka kolaborasi dengan dokter anastesi, tim IKO dan ICU untuk Tindakan operasi SC CITO $\leq$ 30 menit
 - c. Lakukan persiapan pasien operasi SC
 - 3.10. Lakukan transfer pasien dengan di damping oleh bidan dan dokter jaga
 - 3.11. Observasi penuh pasien pasca operasi di ICU
 - 3.12. Lakukan dokumentasi pada rekam medis (Catat semua advis yang diberikan oleh dokter dan Tindakan yang dilakukan kedalam SOAP)

Unit Terkait

1. PONEK IGD
2. MATERNITAS
3. IKO
4. ICU